DB

青 岛 市 服 务 业 标 准 规 范

DB 3702/ FW HLBX 003-2020

长期护理保险照护需求等级评估操作规范

Operation Procedures for Care Level Assessment in Long-term Care Insurance

2020 -05-29 发布　　2020-06-01 实施

青 岛 市 医 疗 保 障 局　发布
青岛市市场监督管理局

目　　次

前　　言 2

引　　言 3

1 范围 4

2 规范性引用文件 4

3 术语和定义 4

4 基本原则 5

5 评估人员要求 5

6 受理 5

7 核对 5

8 预约 5

9 现场评估 5

10 综合评估 6

11 评估结果 6

12 争议处理 8

13 材料归档 8

14 评估结果使用 8

15 评估流程 8

附录 A（资料性附录）青岛市失能失智人员照护需求等级评估申请表 9

附录 B（资料性附录）青岛市失能人员照护需求等级评估表 10

附录 C（资料性附录）青岛市失智人员照护需求等级评估表 19

附录 D（资料性附录）青岛市长期护理保险照护需求等级评估流程图 21

前　言

本标准按照 GB/T 1.1-2009 给出的规则起草。

本标准由青岛市医疗保障局提出并归口。

本标准主要起草单位：青岛市医疗保障事业中心、中国社会保险学会社会保险管理服务专业委员会、山东工商学院。

本标准主要起草人：马青、龚忆莼、李静、张秋立、唐林凤、邓玉华、林君丽、刘湘源、刘楠、孙源、王其峰、石刚、任玥莹、王立永。

引　　言

本标准的制定是为失能失智长期护理保险参保人的照护需求提供统一、规范和可操作的等级评定依据，有利于定点护理服务机构精准对接其照护服务需求，以利政府部门公正、公平、合理确定失能失智人员的保障待遇。

长期护理保险照护需求等级评估操作规范

1 范围

本标准规定了长期护理保险（以下简称“护理保险”）照护需求等级评估操作的基本原则、评估人员要求、受理、核对、预约、现场评估、综合评估、评估结果、争议处理、材料归档、评估结果使用、评估流程等要求。

本标准适用于青岛市行政区域内的护理保险照护需求评估机构对评估对象享受护理保险待遇评估操作。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

MZ/T 039-2013 老年人能力评估

GB/T 31599-2015 社会保险业务档案管理规范

DB 37/T 3694.2-2019 医疗保障

DB 3702/ FW HLBX 001-2019 长期护理保险管理与服务 总则

3 术语和定义

MZ/T 039-2013、GB/T 31599-2015、DB 37/T 3694.2-2019、DB 3702/ FW HLBX 001-2019 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

能力 Ability

个体顺利完成某一活动所必需的主观条件。

[MZ/T 039-2013,2.1]

3.2

日常生活活动 Activity of Daily Living

个体为独立生活而每天必须反复进行的、最基本的、具有共同性的身体动作群，即进行衣、食、住、行、个人卫生等日常活动的基本动作和技巧。

[MZ/T 039-2013,2.2]

3.3

精神状态 Mental Status

个体在认知功能、行为、情绪等方面的外在表现。

[MZ/T 039-2013,2.3]

3.4

感知觉与沟通 Sensory and Communication

个体在意识水平、视力、听力、沟通交流等方面的主观条件。

[MZ/T 039-2013,2.4]

3.5

社会参与 Social Involvement

个体与周围人群和环境的联系与交流状况。

[MZ/T 039-2013,2.5]

4 基本原则

4.1 依法合规

依据相关法律、法规、规章及其他规定性文件，遵循工作规程。

4.2 客观公正

以事实为依据，客观真实、公平公正评估，正确履行职责。

4.3 科学严谨

使用科学工具，严谨实施评估操作，不断优化，提高效率。

4.4 人员回避

评估人员因亲属关系、经济利益关系等可能影响评估工作公正的，应自行回避。

5 评估人员要求

评估人员分为评估员和评估师，应符合以下条件：

a）具有良好的诚信记录，具备医疗、护理、康复或社工专业背景，从事养老服务、长期照护工作一定年限。

b）上岗前应参加照护需求等级评估培训，且培训合格。

c）按照评估工作要求及流程开展评估工作，正确使用评估工具。

d）评估师应具有中级以上职称或经本人所在评估机构推荐，从事过一定年限的评估工作，且具有更高的学历和资质要求，负责评估工作及组织管理。

6 受理

评估机构应核实评估对象身份信息、参保类别及申请材料,包括《青岛市失能失智人员照护需求等级评估申请表》（参见附录 A）、病历资料等。材料完整、齐全的，应予以受理；材料不齐全的，应一次性告知申请人需补充的材料。

7 核对

评估人员应核对评估对象参保类别、现住地址、联系电话等信息。

8 预约

评估人员应与评估对象或其家属预约现场评估事宜，告知现场评估的时间安排及要求。

9 现场评估

9.1 制定方案

现场评估人员应提前制定科学合理的现场评估工作方案，方案内容应包括人员组成与分工、时间与路线安排、现场评估要点等。

9.2 评估用具准备

在实施现场评估前，评估人员应准备《青岛市失能人员照护需求等级评估表》（参见附录 B）、《青岛市失智人员照护需求等级评估表》（参见附录 C）评估工具及状态完好的评估用电子设备等。

9.3 现场评估实施

9.3.1 评估人员入户时，应着装整洁、正确佩戴工作牌，行为举止应符合礼仪规范，使用文明用语。

9.3.2 评估人员应现场核实评估对象身份，收集评估所需资料，利用科学、合理的评估工具，对评估对象的日常生活活动、精神状态、感知觉与沟通、社会参与等能力予以初步评判。确保资料客观、真实，并对收集的资料进行整理汇总。

9.4 评估指标

9.4.1 一级指标共 4 个，包括日常生活活动、精神状态、感知觉与沟通、社会参与。

9.4.2 二级指标共 22 个，参见表 1。

表 1 能力评估指标

一级指标	二级指标
日常生活活动	进食、洗澡、修饰、穿衣、大便控制、小便控制、如厕、床椅转移、平地行走、上下楼梯等
精神状态	认知功能、攻击行为、抑郁症状等
感知觉与沟通	意识水平、视力、听力、沟通交流等
社会参与	生活能力、脑力或体力运作能力、时间/空间定向、人物定向、社会交往能力等

10 综合评估

10.1 制定方案

在现场评估的基础上，评估师应制定综合评估方案，内容包括综合评估人员组成与分工、查阅评估对象相关信息、综合评估要点等。

10.2 综合评估实施

由评估师组织评估员对整理汇总的现场评估资料，按计划进行审定，经集体讨论后得出综合评估初步结论。

11 评估结果

11.1 一级指标分级

11.1.1 日常生活活动：通过对 10 个二级指标的评定，将其得分相加得到总分。总分分为 0（能力完好）、1（轻度受损）、2（中度受损）、3（重度受损）4 个等级，分级标准参见表 2。

表 2 日常生活活动分级标准

分级	分级名称	分级标准
0	能力完好	日常生活活动总分 100 分
1	轻度受损	日常生活活动总分 65-95 分
2	中度受损	日常生活活动总分 45-60 分
3	重度受损	日常生活活动总分≤40 分

11.1.2 精神状态：通过对 3 个二级指标的评定，将其得分相加得到总分。总分分为 0（能力完好）、1（轻度受损）、2（中度受损）、3（重度受损）4 个等级，分级标准参见表 3。

表 3 精神状态分级标准

分级	分级名称	分级标准
0	能力完好	精神状态总分为 0 分
1	轻度受损	精神状态总分为 1 分
2	中度受损	精神状态总分 2-3 分
3	重度受损	精神状态总分 4-6 分

11.1.3 感知觉与沟通：通过对 4 个二级指标的评定，划分为 0（能力完好）、1（轻度受损）、2（中度受损）、3（重度受损）4 个等级，分级标准参见表 4。

表 4 感知觉与沟通分级标准

分级	分级名称	分级标准
0	能力完好	意识清醒，且视力和听力评为 0 或 1，沟通评为 0
1	轻度受损	意识清醒，但视力和听力中至少一项评为 2，或沟通评为 1
2	中度受损	意识清醒，但视力和听力中至少一项评为 3，或沟通评为 2；或嗜睡，视力或听力评定为 3 及以下，沟通评为 2 及以下
3	重度受损	意识清醒或嗜睡，但视力或听力中至少一项评为 4，或沟通评为 3；或昏睡/昏迷

11.1.4 社会参与：通过对 5 个二级指标的评定，将其得分相加得到总分；总分分为 0（能力完好）、1（轻度受损）、2（中度受损）、3（重度受损）4 个等级，分级标准参见表 5。

表 5 社会参与分级标准

分级	分级名称	分级标准
0	能力完好	社会参与总分 0-2 分
1	轻度受损	社会参与总分 3-7 分
2	中度受损	社会参与总分 8-13 分
3	重度受损	社会参与总分 14-20 分

11.2 照护需求等级评估

综合日常生活活动、精神状态、感知觉与沟通、社会参与 4 个一级指标的分级，将评估对象照护需求等级分为 0 级、一级、二级、三级、四级、五级 6 个等级,能力分级标准参见表 6。

表 6 照护需求等级评估标准

能力等级	等级标准
0 级	日常生活活动、精神状态、感知觉与沟通分级均为 0，社会参与分级为 0 或 1。
一级	日常生活活动分级为 0，精神状态、感知觉与沟通中至少一项分级为 1 及以上；或社会参与分级为 2 及以上；或日常生活活动分级为 1，且经日常生活活动分级评分为 85~95 分,精神状态、感知觉与沟通、社会参与中至少有一项的分级为 0 或 1。
二级	日常生活活动分级为 1，且经日常生活活动分级评分为 65~80 分； 或日常生活活动分级为 1，且经日常生活活动分级评分为 85~95 分,但精神状态、感知觉与沟通、社会参与至少有一项为 2 及以上。
三级	日常生活活动能力为 2，且精神状态、感知觉与沟通、社会参与其中 1 项的分级为 2 以下
四级	日常生活活动能力为 2，且精神状态、感知觉与沟通、社会参与均为 2 或其中 1 项的分级为 3; 或日常生活活动分级为 3，且经日常生活活动分级评分为 25-40 分，精神状态、感知觉与沟通、社会参与其中 1 项的分级为 2 以下。
五级	日常生活活动分级为 3，且经日常生活活动分级评分为 25-40 分，精神状态、感知觉与沟通、社会参与均为 2 或至少有 1 项为 3; 或日常生活活动分级为 3，且经日常生活活动分级评分为 0-20 分；或处于昏迷状态；或诊断为重度失智。

11.3 综合评估复审

评估师应对综合评估初步结论进行复审，复审内容包括调阅现场评估采集的信息及资料、综合评估初步结论、护理保险服务形式、评估有效期等，并出具复审意见。

11.4 评估时限

护理保险照护需求评估机构应在受理后规定时限内完成评估。

11.5 评估结果告知

护理保险照护需求评估机构应按照相关要求将评估结果告知评估对象或家属。

12 争议处理

12.1 评估对象对评估结果有异议的，应自收到评估结果之日起，按规定提出复核申请，护理保险照护需求评估机构应重新安排评估人员进行复核，并作出复核评估结果。
12.2 评估对象对复核评估结果仍有异议的，应经主管部门复审后，得出最终结果。

13 材料归档

护理保险照护需求评估机构应按评估流程规范填写工作记录，通过规定的渠道生成评估对象的评估档案，及时归集、整理评估资料，按GB/T 31599-2015的要求归档。

14 评估结果使用

评估结果作为评估对象享受护理保险待遇的依据。

15 评估流程

评估流程《青岛市长期护理保险照护需求等级评估流程图》（参见附录 D） 。

附录 A

（资料性附录）

青岛市失能失智人员照护需求等级评估申请表

青岛市失能失智人员照护需求等级评估申请表

定点护理机构编码：　　年　月　日

<table>
<tr><td>姓名</td><td></td><td>性别</td><td></td><td>出生年月</td><td></td><td>文化程度</td><td></td></tr>
<tr><td>曾经主要职业</td><td></td><td>婚姻状况</td><td></td><td>子女情况</td><td colspan="3">_____子_____女</td></tr>
<tr><td>社保类别</td><td colspan="2">☐职工　☐居民</td><td>身份证号</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>现住址</td><td colspan="2"></td><td>联系电话</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>所属街道居委会</td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td colspan="8">既往病史：
目前病情：
主要诊断：
拟申请服务形式：失能照护 ☐专护　☐院护　☐家护　☐巡护　☐日间照护
失智照护 ☐院护　☐家护　☐日间照护
养老服务待遇　☐入住机构运营补贴　☐签约家庭养老床位运营补贴
其他_____</td></tr>
<tr><td colspan="8">温馨提示：根据有关规定，失能失智者申请享受某种社会保障待遇，必须接受专业人员对本人的经济状况、生活环境、病情及自理能力的评估。相关工作人员将登门调查生活环境等情况，并实施查看病历资料、询问病情、查体等工作，根据需要，可能还要录音、录像以及采集指纹信息等，申请人及家属应给予积极配合。不予配合、无法完成相关评估和确认工作的，将终止待遇核准。
请将身份证复印件粘贴于本表背面。
☐本人已认真阅读上述内容，理解并愿意配合做好上述工作。

申请人签字：　　监护人签字：
监护人与申请人关系 ：
年　月　日</td></tr>
<tr><td colspan="8">受理机构（部门）意见：
（公章）

负责人签字：
年　月　日</td></tr>
</table>

本表由受理机构（部门）负责发放并指导申请人填写。由照护机构受理的一式 2 份，照护机构与申请人各 1 份；由评估机构受理的一式 2 份，评估机构与申请人各 1 份。

附录 B

（资料性附录）

青岛市失能人员照护需求等级评估表

青岛市失能人员照护需求等级评估表
（2020 版）

申请人姓名_____

评估表编号_____

评估类别 □ 首次评估
□ 后续评估 第_____次评估（含首次）
□ 争议评估 （□ 复核 □ 复审）

_____年_____月_____日

A.基本情况调查

A.1基本信息

A.1.1 姓名		A.1.2 性别	1 男　2 女　□
A.1.3 出生日期	年　月　日	A.1.4 民族	1 汉族　2 少数民族_____　□
A.1.5 身份证号		A.1.6 社保卡号	
A.1.7 户籍所在地		A.1.8 居住地	
A.1.9 文化程度	1 文盲　2 小学　3 初中　4 高中/技校/中专　5 大学专科及以上　6 不详　□		
A.1.10 婚姻状况	1 未婚　2 已婚　3 丧偶　4 离婚　5 未说明的婚姻状况　□		
A.1.11 经济状况	A.1.11.1 人员类别	1 离休　2 退休（含退职）　3 在职　4 居民　5 低保户　6 低保边缘户 7 城乡特困人员 8 其他_____　□	
	A.1.11.2 医疗费用支付方式	1 职工基本医疗保险　2 居民基本医疗保险 3 医疗救助　4 商业医疗保险 5 自费　6 其他　□	
A.1.12 生活环境	A.1.12.1 居住状况	1 与子女同住　2 与其他亲属同住　3 空巢（有或无子女，有配偶） 4 独居　5 已入住养老机构　6 其他　□	
	A.1.12.2 居住安全	1 居所安全设施完备，无需改进 2 可改进的不安全因素：_____ 3 不可改进的不安全因素：_____　□	
	A.1.12.3 居住楼层	1 一或二楼较方便　2 三楼以上无电梯　3 楼房有电梯　□	
	A.1.12.4 洗浴设施	1 独用　2 合用　3 无　□	
A.1.13 家庭支持	A.1.13.1 家庭支持状况	1 提供足够的物质和情感支持　2 仅提供物质支持 3 仅提供情感支持　4 缺乏物质和情感支持　□	
	A.1.13.2 家庭经济状况	1 家庭年收入 2 万以下　2 家庭年收入 2-5 万　3 家庭年收入 5-10 万 4 家庭年收入 10-20 万　5 家庭年收入 20 万以上　□	
	A.1.13.3 照护者身份	1 配偶　2 子女　3 亲戚朋友 4 保姆　5 无照护者　6 其他　□	
	A.1.13.4 照护者或被评估者对照护方式的意见	1 居家照护　2 日间照护　3 入住机构　□	

A.2.1 疾病状况	A.2.1.1 就医方式	1 居家医疗　2 外出就诊　习惯就医地点为_____		□
	A.2.1.2 神经系统	疾病类别或名称	程度或主要合并症	
		□脑血管疾病、中枢神经系统感染	1 左侧偏瘫 2 右侧偏瘫 3 左侧上肢 4 左侧下肢 5 右侧上肢 6 右侧下肢 7 全瘫 8 其他_____	□
			1 肌力 0 级 2 肌力Ⅰ级 3 肌力Ⅱ级 4 肌力Ⅲ级 5 肌力Ⅳ级 6 肌力Ⅴ级	□
		□运动障碍与神经变性疾病（运动神经元疾病等）	1 运动障碍 2 感觉障碍 3 吞咽障碍 4 呼吸障碍 5 截瘫 6 其他_____	□
			1 肌力 0 级 2 肌力Ⅰ级 3 肌力Ⅱ级 4 肌力Ⅲ级 5 肌力Ⅳ级 6 肌力Ⅴ级	□
		□癫痫	1 大发作 2 小发作 3 精神运动发作 4 其他_____	□
		□帕金森氏综合症	1 震颤 2 活动障碍 3 僵直 4 其他_____	□
		□认知功能障碍与痴呆	1 轻度 2 中度 3 重度	□
		□其他		
	A.2.1.3 心血管系统	□高血压病	1 高血压病 1 级 2 高血压病 2 级 3 高血压病 3 级	□
		□冠心病	1 心功能Ⅰ级 2 心功能Ⅱ级 3 心功能Ⅲ级 4 心功能Ⅳ级	□
		□其他		
	A.2.1.4 呼吸系统	□慢性阻塞性肺疾病	1 肺功能Ⅰ级（基本正常） 2 肺功能Ⅱ级（稍有减退） 3 肺功能Ⅲ级（显著减退） 4 肺功能Ⅳ级（严重损害） 5 肺功能Ⅴ级（呼吸衰竭）	□
		□肺心病	1 心功能Ⅰ级 2 心功能Ⅱ级 3 心功能Ⅲ级 4 心功能Ⅳ级	□
		□肺纤维化	1 早期 2 中后期	
		□其他		
	A.2.1.5 内分泌系统	□糖尿病	1 糖尿病 1 型 2 糖尿病 2 型	□
			1 糖尿病眼病 2 糖尿病坏疽 3 糖尿病肾病 4 其他_____	□
		□甲状腺疾病	1 甲状腺危象 2 其他_____	□
		□其他		
	A.2.1.6 消化系统	□消化性溃疡	1 出血 2 穿孔 3 幽门梗阻 4 恶变 5 其他_____	□
		□消化道出血	1 呕血 2 黑粪 3 昏厥 4 休克 5 贫血 6 发热	□
		□肝、胆疾病	1 肝硬化 2 胆石症 3 胆囊炎	□
		□其他		
	A.2.1.7 泌尿系统	□慢性肾功能不全	1 代偿期 2 功能不全期 3 衰竭期 4 尿毒症期	□
		□前列腺疾病	1 感染 2 肥大	□
		□其他		
	A.2.1.8 运动系统	□骨质疏松	1 轻度 2 重度	□
		□骨折	1 上肢 2 下肢 3 髋部 4 脊柱 5 其他_____	□
			1 坠积性肺炎 2 下肢深静脉血栓形成 3 压疮	□
		□骨关节病	1 活动障碍 2 关节轻度变形 3 多个关节严重变形 4 其他_____	□
		□其他		
	A.2.1.9 感觉系统	□白内障	1 失明 2 光感 3 其他_____	□
		□视网膜病变	1 失明 2 光感 3 其他_____	□
		□其他		
	A.2.1.10 其他疾病	□恶性肿瘤	1 恶病质 2 其他_____	□
		□其他		
A.2.2 特殊医疗护理需求	A.2.2.1 近两年医药费使用情况	1 年均 5 千元以下 2 年均 5 千-1 万 3 年均 1 万-2 万 4 年均 2 万元以上		□
	A.2.2.2 最后一次出院护理级别	1 特级护理 2 一级护理 3 二级护理 4 三级护理		□
	A.2.2.3 意识状态	1 清醒 2 模糊 3 嗜睡 4 昏迷 5 其他_____		□
	A.2.2.4 管道留置	1 鼻胃管 2 导尿管 3 气管套管 4 其他_____		□
	A.2.2.5 呼吸机使用情况（有创/无创）	1 持续使用 2 间断使用 3 其他_____		□
	A.2.2.6 压疮	1 可疑的深部组织损伤 2Ⅰ期 3Ⅱ期 4Ⅲ期 5Ⅳ期 6 不明确分期		□
	A.2.2.7 近两年住院	1 无 2 一次 3 二次 4 三次 5 四次以上		□
A.2.3 近 30 天内意外事件	A.2.3.1 跌倒	1 无 2 发生过 1 次 3 发生过 2 次 4 发生过 3 次以上		□
	A.2.3.2 噎食	1 无 2 发生过 1 次 3 发生过 2 次 4 发生过 3 次以上		□
	A.2.3.3 自杀	1 无 2 发生过 1 次 3 发生过 2 次 4 发生过 3 次以上		□
	A.2.3.4 走失	1 无 2 发生过 1 次 3 发生过 2 次 4 发生过 3 次以上		□
	A.2.3.5 其他			
A.2.4 营养状况	A.2.4.1 过去三个月中，是否因食欲不振，咀嚼或吞咽困难，消化不良等问题导致进食量越来越少?	1 厌食 2 食欲不振 3 食欲正常		□
	A.2.4.2 近三个月体重变化	1 体重减轻 >3 公斤 2 体重减轻 1-3 公斤 3 体重无改变 4 不清楚		□
	A.2.4.3 身体质量指数(BMI) 体重(公斤) /身高(公尺)^2	1 BMI < 18.5 2 18.5≦ BMI < 24 3 24≦ BMI < 28 4 28≦ BMI ≦ 32 5 BMI＞32		□
	A.2.4.4 小腿围（CC）（cm）（若无 BMI）	1 CC＜31 2 CC≧ 31		□

A.2健康状况

A.3信息提供者及联系人信息

A.3.1 信息提供者与被评估者的关系	1 配偶　2 子女　3 其他亲属　4 雇佣照顾者　5 其他　□
A.3.2 联系人（主要监护人）	姓名：　1 配偶　2 子女　3 其他　□
A.3.3 联系人电话	
A.3.4 信息提供者签名	

说明：此表选项可做多项选择

B. 能力评估

B．1 日常生活活动评估表

B.1.1 进食： 指用餐具将食 物由容器送到口中、咀嚼、吞咽等过程	□分	10 分，可独立进食（在合理的时间内独立进食准备好的食物）
		5 分， 需部分帮助（进食过程中需要一定帮助，如协助把持餐具）
		0 分， 需极大帮助或完全依赖他人，或通过鼻饲管进食
B.1.2 洗澡	□分	5 分， 准备好洗澡水后，可自己独立完成洗澡过程
		0 分， 在洗澡过程中需他人帮助
B.1.3 修饰： 指洗脸、刷牙、梳头、刮脸等	□分	5 分， 可自己独立完成
		0 分， 需他人帮助
B.1.4 穿衣： 指穿脱衣服、拉拉链、穿脱鞋袜、系鞋带等	□分	10 分，可独立完成
		5 分，需部分帮助（能自己穿脱，但需他人帮助整理衣物、系扣/鞋带、拉拉链）
		0 分， 需极大帮助或完全依赖他人
B.1.5 **大便控制**	□分	10 分，可控制大便
		5 分， 偶尔失控（每周<1 次），或需要他人提示
		0 分， 完全失控
B.1.6 **小便控制**	□分	10 分，可控制小便
		5 分， 偶尔失控（每天<1 次，但每周>1 次），或需要他人提示
		0 分， 完全失控，或留置导尿管
B.1.7 如厕： 包括去厕所、解开衣裤、擦净、整理衣裤、冲水	□分	10 分，可独立完成
		5 分， 需部分帮助（需他人搀扶去厕所、需他人帮忙冲水或整理衣裤等）
		0 分， 需极大帮助或完全依赖他人
B.1.8 **床椅转移**	□分	15 分，可独立完成
		10 分，需部分帮助（需他人搀扶或使用拐杖）
		5 分， 需极大帮助（2 人，能坐）
		0 分， 完全依赖他人
B.1.9 **平地行走**	□分	15 分，可独立在平地上行走（可用辅助器具）
		10 分，需部分帮助（因肢体残疾、平衡能力差、过度衰弱、视力等问题，在一定程度上需他人搀扶）
		5 分， 需极大帮助（因肢体残疾、平衡能力差、过度衰弱、视力等问题，在较大程度上依赖他人搀扶，或坐在轮椅上自行移动）
		0 分， 完全依赖他人
B.1.10 **上下楼梯**	□分	10 分，可独立上下楼梯
		5 分，需部分帮助（需他人搀扶，或扶着楼梯、使用拐杖等）
		0 分，完全依赖他人
B.1. 11 **日常生活活动总分**	□分	上述 10 个项目得分之和
B.1.12 **日常生活活动分级**	□级	0 能力完好：总分 100 分 1 轻度受损：总分 65-95 分 2 中度受损：总分 45-60 分 3 重度受损：总分≦40 分

B.2 精神状态评估表

<table>
<tr><td rowspan="5">B.2.1
认知功能：
此项绝大多数失能人员无法配合</td><td rowspan="3">测验</td><td>“我说三样东西，请重复一遍，并记住，一会儿会问您”：苹果、手表、国旗</td></tr>
<tr><td>(1)画钟测验：“请在这儿画一个圆形时钟，在时钟上标出 10 点 45 分”</td></tr>
<tr><td>(2)回忆词语：“现在请您告诉我，刚才我要您记住的三样东西是什么？”
答：_____、_____、_____（不必按顺序）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">评分
□分</td><td>0 分，画钟正确（画出一个闭锁圆，指针位置准确），且能回忆出 2-3 个词</td></tr>
<tr><td>1 分，画钟错误（画的圆不闭锁，或指针位置不准确），或只回忆出 0-1 个词</td></tr>
<tr><td>2 分，已确诊为认知障碍，如老年痴呆</td></tr>
<tr><td rowspan="3">B.2.2
攻击行为</td><td rowspan="3">□分</td><td>0 分，无身体攻击行为（如打/踢/推/咬/抓/摔东西）和语言攻击行为（如骂人、语言威胁、尖叫）</td></tr>
<tr><td>1 分，每月有几次身体攻击行为，或每周有几次语言攻击行为</td></tr>
<tr><td>2 分，每周有几次身体攻击行为，或每日有语言攻击行为</td></tr>
<tr><td rowspan="3">B.2.3
抑郁症状</td><td rowspan="3">□分</td><td>0 分，无</td></tr>
<tr><td>1 分，情绪低落、不爱说话、不爱梳洗、不爱活动</td></tr>
<tr><td>2 分，有自杀念头或自杀行为</td></tr>
<tr><td>B.2.4 精神状态总分</td><td>□分</td><td>上述 3 个项目得分之和</td></tr>
<tr><td>B.2.5 精神状态分级</td><td>□级</td><td>0 能力完好：总分为 0 分
1 轻度受损：总分为 1 分
2 中度受损：总分 2-3 分
3 重度受损：总分 4-6 分</td></tr>
</table>

B．3 感知觉与沟通评估表

B.3.1 **意识水平**	□分	0 分，神志清醒，对周围环境警觉
		1 分，嗜睡，表现为睡眠状态过度延长。当呼唤或推动其肢体时可唤醒，并能进行正确的交谈或执行指令，停止刺激后又继续入睡
		2 分，昏睡，一般的外界刺激不能使其觉醒，给予较强烈的刺激时可有短时的意识清醒，醒后可简短回答提问，当刺激减弱后又很快进入睡眠状态
		3 分，昏迷，处于浅昏迷时对疼痛刺激有回避和痛苦表情；处于深昏迷时对刺激无反应（若评定为昏迷，直接评定为重度失能，可不进行以下项目的评估）
B.3.2 视力： 若平日带老花镜或近视镜，应在佩戴眼镜的情况下评估	□分	0 分，能看清书报上的标准字体
		1 分，能看清楚大字体，但看不清书报上的标准字体
		2 分，视力有限，看不清报纸大标题，但能辨认物体
		3 分，辨认物体有困难，但眼睛能跟随物体移动，只能看到光、颜色和形状
		4 分，没有视力，眼睛不能跟随物体移动
B.3.3 听力： 若平时佩戴助听器，应在佩戴助听器的情况下评估	□分	0 分，可正常交谈，能听到电视、电话、门铃的声音
		1 分，在轻声说话或说话距离超过 2 米时听不清
		2 分，正常交流有些困难，需在安静的环境或大声说话才能听到
		3 分，讲话者大声说话或说话很慢，才能部分听见
		4 分，完全听不见
B.3.4 **沟通交流:** 包括非语言沟通	□分	0 分，无困难，能与他人正常沟通和交流
		1 分，能够表达自己的需要及理解别人的话，但需要增加时间或给予帮助
		2 分，表达需要或理解有困难，需频繁重复或简化口头表达
		3 分，不能表达需要或理解他人的话
B.3.5 感知觉与沟通分级	□级	0 能力完好：意识清醒，且视力和听力评为 0 或 1，沟通评为 0 1 轻度受损：意识清醒，但视力或听力中至少一项评为 2，或沟通评为 1 2 中度受损：意识清醒，但视力或听力中至少一项评为 3，或沟通评为 2；或嗜睡，视力或听力评定为 3 及以下，沟通评定为 2 及以下 3 重度受损：意识清醒或嗜睡，但视力或听力中至少一项评为 4，或沟通评为 3；或昏睡/昏迷

B．4 社会参与评估表

B.4.1 **生活能力**	□分	0 分，除个人生活自理外（如饮食、洗漱、穿戴、二便），能料理家务（如做饭、洗衣、擦玻璃、铺床等）或当家管理事务（如钱财管理）
		1 分，除个人生活自理外，能做家务（如洗碗、叠被、整理衣物等），但欠好，家庭事务安排欠条理
		2 分，个人生活能自理；只有在他人帮助下才能做些家务，但质量不好
		3 分，个人基本生活事务能自理（如饮食、二便），在督促下可洗漱
		4 分，个人基本生活事务（如饮食、二便）需要部分帮助或完全依赖他人帮助
B.4.2 **脑力或体力运作能力**	□分	0 分，原来熟练的脑力工作或体力技巧性工作可照常进行
		1 分，原来熟练的脑力工作或体力技巧性工作能力有所下降
		2 分，原来熟练的脑力工作或体力技巧性工作明显不如以往，部分遗忘
		3 分，对熟练工作只有一些片段保留，技能全部遗忘
		4 分，对以往的知识或技能全部磨灭
B.4.3 **时间/空间定向**	□分	0 分，时间观念（年、月、日、时）清楚；可单独出远门，能很快掌握新环境的方位
		1 分，时间观念有些下降，年、月、日清楚，但有时相差几天；可单独来往于近街，知道现住地的名称和方位，但不知回家路线
		2 分，时间观念较差，年、月、日不清楚，可知上半年或下半年；只能单独在家附近行动，对现住地只知名称，不知道方位
		3 分，时间观念很差，年、月、日不清楚，可知上午或下午；只能在左邻右舍间串门，对现住地不知名称和方位
		4 分，无时间观念或不能单独外出
B.4.4 **人物定向**	□分	0 分，知道周围人们的关系，知道祖孙、叔伯、姑姨、侄子侄女等称谓的意义；可分辨陌生人的大致年龄和身份，可用适当称呼
		1 分，只知家中亲密近亲的关系（包括经常服务的医务人员、社工、护理员等），不会分辨陌生人的大致年龄，不能称呼陌生人
		2 分，只能称呼家中人，或只能照样称呼，不知其关系，不辨辈分
		3 分，只认识常同住的亲人，可称呼子女或孙子女，可辨熟人和生人
		4 分，只认识保护人，不辨熟人和生人
B.4.5 **社会交往能力**	□分	0 分，参与社会，在社会环境有一定的适应能力，待人接物恰当
		1 分，能适应单纯环境（如社区日间照料中心、养老机构内环境等），主动接触人，初见面时难让人发现智力问题，不能理解隐喻语
		2 分，脱离社会，可被动接触，不会主动待人，谈话中很多不适词句，容易上当受骗
		3 分，勉强可与人交往，谈吐内容不清楚，表情不恰当
		4 分，难以与人接触
B.4.6 社会参与总分	□分	上述 5 个项目得分之和
B.4.7 社会参与分级	□级	0 能力完好：总分 0-2 分 1 轻度受损：总分 3-7 分 2 中度受损：总分 8-13 分 3 重度受损：总分 14-20 分

照护需求等级评估结果

1 现场评估

维度分级	1.1 日常生活活动：□级	1.2 精神状态：□级
	1.3 感知觉与沟通：□级	1.4 社会参与：□级

2 综合评估

2.1 综合评估标准	**0 级** 日常生活活动、精神状态、感知觉与沟通分级均为 0，社会参与分级为 0 或 1。 **一级** 日常生活活动分级为 0，精神状态、感知觉与沟通中至少 1 项分级为 1 及以上，或社会参与的分级为 2 及以上； 或日常生活活动分级为 1，且日常生活活动分级评分为 85~95 分,精神状态、感知觉与沟通、社会参与中至少有一项的分级为 0 或 1。 **二级** 日常生活活动分级为 1，且日常生活活动分级评分为 65~80 分； 或日常生活活动分级为 1，且日常生活活动分级评分为 85~95 分,精神状态、感知觉与沟通、社会参与至少有一项为 2 及以上 **三级** 日常生活活动能力为 2，精神状态、感知觉与沟通、社会参与分级均为 3 以下且至少 1 项为 2 以下。 **四级** 日常生活活动能力为 2，精神状态、感知觉与沟通、社会参与分级均为 2 或至少 1 项为 3; 或日常生活活动分级为 3，且日常生活活动分级评分为 25-40 分，精神状态、感知觉与沟通、社会参与分级均为 3 以下且至少 1 项为 2 以下。 **五级** 日常生活活动分级为 3，且日常生活活动分级评分为 25-40 分，精神状态、感知觉与沟通、社会参与分级均为 2 或至少 1 项为 3; 或日常生活活动分级为 3，且经日常生活活动分级评分为 0-20 分；或处于昏迷状态；或诊断为重度失智。
2.2 综合评估结论	□0 级　□一级　□二级　□三级　□四级　□五级 本次评估有效期　月
注：1：经指定医疗机构及专家诊断有认知障碍/痴呆，评估等级为三、四级的可在原有能力级别上提高一个级别。 2：年龄在 85 岁以上者，日常生活活动能力评分为 65 分的，日常生活活动分级可认定为 2。	
现场评估人员签名_____、_____； 综合评估人员签名_____、_____评估师签名_____； 年　月　日	

注：本评估表由评估机构存档。

附录 C

（资料性附录）

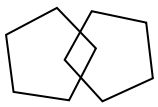
青岛市失智人员照护需求等级评估表

青岛市失智人员照护需求等级评估表

评估机构：　（章）　　评估时间：　年　月 日

姓名		性　别		出生年月		文化程度		职　业	
身份证号			人员类别	职工□ 居民一档□ 居民二档□		子女情况		婚姻状况	
家属对失智人员的病史及病情（含基础疾病）陈述： 与失智人员的关系：　　家属（签字）：									

项目		最高分	评分
定向力 （10 分）	今年是哪一年	1	
	现在是什么季节？	1	
	现在是几月份？	1	
	今天是几号？	1	
	今天是星期几？	1	
	您住在那个省？	1	
	您住在那个县（区）？	1	
	您住在那个村/组（街道）？	1	
	我们现在在什么地方？（这是哪里？）	1	
	我们现在在第几层楼？	1	
记忆力 （3 分）	现在我告诉您三种东西（任意与他生活工作相关的物品），我说完后，请你重复一遍并记住，待会还会问你（各 1 分，共 3 分）	3	
注意力 和计算力 （5 分）	100-7=？连续减 5 次（93、86、79、72、65。各 1 分，共 5 分。若错了，但下一个答案正确，只记一次错误）	5	
回忆能力 （3 分）	现在请您说出我刚才告诉您让您记住的那些东西？	3	
	出示手表，问这个是什么东西？	1	
	出示钢笔，问这个是什么东西？	1	
	我现在说一句话，请跟我清楚的重复一遍（四十四只石狮子）！	1	

语言能力 (9 分)	（闭上你的眼睛）请你念念这句话，并按上面意思去做！	1	
	我给您一张纸请您按我说的去做，现在开始：“用右手拿着这张纸，用两只手将它对折起来，放在您的左腿上。”（右手拿纸、把纸对折、放在腿上，每个动作 1 分，共 3 分）	3	
	书写能力要求受试者自己写一句完整的句子/口述一句完整的，有意义的句子（句子必须有主语，动词）记录所述句子的全文。	1	
	（出示图案）请你照上面图案画下来！ 	1	
评估机构评估结论	□轻度　□中度　□重度 现场评估人员签名_____、_____； 综合评估人员签名_____、_____ 评估师签名_____ 年　月　日	合计	

本表一式二份

判定标准：1.认知功能障碍：最高得分为 30 分,分数在 27-30 分为正常,分数<27 为认知功能障碍。
2.按受试者受教育程度进行认知障碍评分修正：文盲≤17 分，小学程度≤20 分，中学程度（包括中专）≤22 分，大学程度（包括大专）≤23 分。
3.认知功能障碍严重程度分级:轻度 MMSE≥21 分;中度,MMSE 10-20 分;重度,MMSE≤9 分。

附录 D

（资料性附录）

青岛市长期护理保险照护需求等级评估流程图

